

Trabajo Práctico N° 25: Otras Demencias

1. Completar el siguiente cuadro:

Tipo de demencia	Neuropatología	Principales estructuras afectadas	Manifestaciones clínicas y cognitivas
Alzheimer	Depósitos betaamiloideos extracelulares (placas neuríticas) y formación intracelular de ovillos neurofibrilares dependientes de la proteína tau. Hay pérdida sináptica y neuronal selectiva.	Predominio en regiones temporolímbicas (hipocampo, lóbulo temporal medial) y neocórtexes de asociación (bitemporal y parietal).	Memoria reciente alterada (déficits de aprendizaje y almacenamiento, olvidos rápidos) es el síntoma inicial más frecuente. Deterioro de lenguaje (dificultad para encontrar palabras), apraxias , agnosias , y sutiles déficits ejecutivos . Apatía , depresión , agitación son síntomas neuropsiquiátricos comunes.
DFT Variante conductual	El hallazgo macroscópico es la atrofia lobar . Microscópicamente, puede ser tipo Pick (cuerpos de Pick argirófilos, tau positivos), degeneración del lóbulo frontal (tau negativo / ubiquitina negativo), o DFT asociada a enfermedad de motoneurona.	Regiones prefrontales y región anterior de los lóbulos temporales . La atrofia puede ser asimétrica en fases iniciales.	Declinación precoz en la conducta social y el manejo personal. Desinhibición social , pérdida temprana de la conciencia de enfermedad (insight), rigidez mental , cambios en la dieta (hiperoralidad, preferencia por dulces) o apatía marcada. Déficits ejecutivos con relativa preservación de la memoria (fallas en la evocación) y habilidades visuoperceptuales en etapas iniciales.
Demencia Vascular	Lesiones vasculares cerebrales (isquémicas o hemorrágicas). Puede incluir infartos lacunares e hiperintensidades de la sustancia blanca (daño microvascular).	El patrón es heterogéneo. Incluye múltiples infartos corticales o infartos en sitios estratégicos (ej., tálamo, núcleo caudado, giro angular izquierdo). La enfermedad de pequeño vaso afecta la sustancia blanca subcortical .	Perfil sumamente heterogéneo. Predomina la disfunción ejecutiva (lentitud del procesamiento de la información, perseveración, dificultad en el manejo de información). Puede ser un patrón cortical (afasia, agnosia) o subcortical (atención, fluidez verbal).
Demencia por Cuerpos de Lewy	Cuerpos de Lewy distribuidos de forma difusa en la corteza cerebral .	Corteza cerebral .	Fluctuación cognitiva , alucinaciones visuoespaciales , trastornos de conducta asociados al sueño REM (RBD) y signos extrapiramidales (parkinsonismo leve). Trastornos en la atención y en las funciones ejecutivas . Frecuente disfunción ejecutiva con fluctuaciones atencionales y problemas en la memoria de trabajo espacial .

Parálisis Supranuclear Progresiva	Patología tau-positiva. Presenta 2 bandas de tau de 64 y 69 kDa.	Afectación del circuito fronto-subcortical . Se afectan el tronco cerebral , los ganglios basales y el cerebelo .	Trastornos motores tempranos: alteraciones en la marcha, pérdida de reflejos posturales (caídas hacia atrás), rigidez axial y parálisis de la mirada vertical. Enlentecimiento en la velocidad de procesamiento . Dificultades en la memoria (evocación espontánea alterada con almacenamiento conservado). Trastornos ejecutivos (flexibilidad de pensamiento, memoria de trabajo). Apatía e irritabilidad .
Degeneración Corticobasal	Pérdida neuronal asimétrica en la corteza frontal y parietal , sustancia nigra y núcleos subcorticales . Puede tener patología tau positiva.	Corteza frontal y parietal , sustancia nigra, núcleos subcorticales. Afectación de estructuras fronto-parietales.	Síntomas motores como acinetorigidez unilateral , inestabilidad postural, mioclonos focales. Hallazgos altamente sugestivos: apraxia unilateral (ideomotora) y síndrome de la mano ajena . Disfunción ejecutiva , afasia no fluente o transcortical motora , y fallas leves en memoria episódica.
Atrofia Cortical Posterior	La fuente menciona una variante de presentación visuoespacial cortical posterior de la Enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la neuropatología y las estructuras específicas de la ACP como entidad independiente no se detallan en el material proporcionado.	La fuente menciona que las funciones visuoespaciales son notoriamente deterioradas en la EA, lo cual podría estar implicado.	Se reconoce como una variante de presentación no amnésica de la EA, afectando inicialmente las habilidades visuoespaciales .
Enfermedad de Huntington	Atrofia generalizada.	Ganglios basales . El patrón cognitivo sigue un síndrome fronto-subcortical .	Triada clásica : movimientos anormales (corea), síntomas psiquiátricos y demencia . Los trastornos cognitivos son fundamentales y tempranos . Dificultades ejecutivas (planificación, organización, perseveración) y atencionales. En memoria, hay fallas en la adquisición y en el recuerdo espontáneo, con almacenamiento conservado (mejora con claves). Cambios de personalidad (irritabilidad, ira), depresión , y apatía son comunes.

2. ¿Cuál es el perfil fronto- subcortical? ¿Qué enfermedades lo presentan?

El **perfil cognitivo fronto-subcortical** (o síndrome disejecutivo fronto-subcortical) describe un patrón específico de disfunción cognitiva y conductual. Este síndrome se asocia a la disfunción o daño en los **circuitos fronto-subcorticales**, que conectan la corteza frontal con los ganglios basales y el tálamo.

Características Clave del Perfil Fronto-Subcortical:

1. **Bradifrenia (Enlentecimiento del Procesamiento):** Un enlentecimiento general en el procesamiento de la información, haciendo que el paciente necesite más tiempo para responder preguntas o resolver problemas.
2. **Disfunción Ejecutiva:** Dificultades notables en las funciones ejecutivas, incluyendo la flexibilidad de pensamiento, la capacidad de planificación, la lentitud del procesamiento, las alteraciones en la habilidad de cambiar de una función (perseveración), y déficits en la habilidad de mantener y manipular la información.
3. **Memoria (Falla en la Recuperación):** Los trastornos de la memoria se centran en la evocación espontánea (recuerdo libre) de la información, más que en el almacenamiento per se. El paciente se beneficia notablemente si se le dan pistas o se le proponen opciones múltiples para el reconocimiento.
4. **Cambios Neuropsiquiátricos:** Alteraciones del afecto, destacando la apatía, depresión, irritabilidad, y pérdida de interés.

Enfermedades Típicas del Perfil Fronto-Subcortical:

- Parálisis Supranuclear Progresiva
- Enfermedad de Huntington
- Enfermedad de Parkinson
- Atrofia Multisistémica
- Demencia Vascular
- Hidrocéfalo Normotensivo
- Demencia por VIH

Grupo:

- Juana Saiz Miramon
- Franco Mendez Casariego